TÓM TẮT LÝ THUYẾT · TAI - MŨI - HỌNG

BÀI 2 Chảy máu mũi

Tóm tắt từ bài giảng 2. CHAY MAU MUI 1.pdf (60 trang) · Giữ ý chính và số liệu cần nhớ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ ĐỊNH NGHĨA
2. GIẢI PHẪU MẠCH MÁU
3. PHÂN LOẠI
4. NGUYÊN NHÂN
5. LÂM SÀNG
6. CẬN LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÁN
7. XỬ TRÍ BAN ĐẦU
8. PHẪU THUẬT VÀ CAN THIỆP

1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ ĐỊNH NGHĨA

- Chảy máu mũi là **nguyên nhân thường gặp hàng đầu trong cấp cứu TMH**.
- Thế giới ước tính **108/100.000 dân/năm**; Anh và Wales khoảng **10,2/100.000**; Mỹ **17/100.000 (khoảng 6%)**.
- **Định nghĩa:** tổn thương mạch máu gây chảy máu tại vùng mũi; là **triệu chứng của nhiều bệnh lý** (bất thường niêm mạc, bệnh mạch máu...).

2. GIẢI PHẪU MẠCH MÁU

- Mũi được cấp máu bởi **hệ ĐM cảnh ngoài** (ĐM hàm → **ĐM bướm khẩu cái**, ĐM khẩu cái lớn; ĐM mặt → ĐM môi trên) và **hệ ĐM cảnh trong** (ĐM mắt → **ĐM sàng trước, sàng sau**).
- **Đám rối Kisselbach (vùng Little):** đám rối mao mạch dày đặc dưới niêm mạc ở **vùng trước dưới vách ngăn**, cách **cửa mũi trước 1,5 cm**, **trên sàn mũi 1 cm**.
- **Đám rối Woodruff: đám rối tĩnh mạch** ở **thành bên, phía sau đuôi cuốn mũi dưới**, cách sàn mũi 1 cm; **Woodruff mô tả năm 1949**.

3. PHÂN LOẠI

	Chảy máu mũi trước	Chảy máu mũi sau
Tần suất	**Thường gặp hơn**	Ít gặp, **khoảng 20%**
Vị trí	**Vùng Little** (Kisselbach), phần trước thành mũi bên	Khó xác định, thường **vùng sau trên hốc mũi**
Mức độ	Thường **nhẹ**, kiểm soát được	**Nguy hiểm hơn**, thường tự phát
Đối tượng	**Trẻ em, người trẻ**	Đa số **> 40 tuổi**

4. NGUYÊN NHÂN

- **Nguyên phát (80 – 90%):** mọi lứa tuổi nhưng thường **trẻ em, thanh thiếu niên**; chảy tự nhiên, **tái diễn**, lượng ít, **tự cầm**, đến tuổi trưởng thành thì hết; do **khô niêm mạc** hoặc tiếp xúc tác nhân kích thích.
- **Thứ phát:**

Tại chỗ	Toàn thân
Chấn thương (kể cả ngoáy mũi, dụng cụ)	**Thuốc: Coumadin, NSAID, aspirin**
Phẫu thuật (xoang, nội soi nền sọ)	Rối loạn đông chảy máu
Lệch vách ngăn, gai vách	Bệnh ác tính về máu
U mũi xoang (lành, mạch máu, ác tính)	**Tăng huyết áp**

Tại chỗ	Toàn thân
Dị vật	Bệnh gan mật
Viêm, bệnh u hạt	Nghiện rượu
Thuốc dùng tại chỗ (xịt mũi)	Bệnh mạch máu, mô liên kết
Độ ẩm thấp	Suy dinh dưỡng

5. LÂM SÀNG

- **Trẻ em:** thường tái phát, **nguyên phát**, hay xảy ra **ban đêm**; vị trí **trước dưới vách ngăn**; liên quan viêm, nhiễm trùng mạch máu dễ vỡ; **ngoáy mũi** gây viêm tiền đình mũi.
- **Người lớn:** thể thường gặp nhất trong bệnh viện; điểm mạch thường **ở phía sau**, vùng **trên sau vách ngăn** – nơi **nối nhánh ĐM cảnh trong và cảnh ngoài**; chảy từ thành bên thì xử trí rất khó.
- **Mức độ:**
  - **Nhẹ:** ít, nhỏ giọt, **có xu hướng tự cầm**.
  - **Trung bình:** chảy từ điểm mạch, **thành dòng đỏ tươi** ra cửa mũi trước hoặc xuống họng, kéo dài; toàn thân ít ảnh hưởng.
  - **Nặng: vỡ mạch máu lớn**, mất máu nhiều, kéo dài, tái phát; **toàn thân ảnh hưởng rõ**.

6. CẬN LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÁN

- **Xét nghiệm huyết học** (TS, tiểu cầu, TP, aPTT):
  - TS tăng + **tiểu cầu thấp** → **giảm tiểu cầu**.
  - TS tăng + tiểu cầu bình thường + **aPTT tăng** → **bệnh Von Willebrand**.
  - TS bình thường + **aPTT tăng đơn độc** → thiếu yếu tố **VIII, IX, XI, XII**.
- **Nội soi:** khi chảy máu cấp hoặc tái phát mà **soi mũi trước không xác định được vị trí**.
- **CT scan:** tìm nguyên nhân, nhất là **khối u mũi xoang, chấn thương hàm mặt**.
- **Chụp mạch đồ:** tổn thương mạch máu chính, **u mạch máu** (u xơ vòm), **giả phình mạch do chấn thương**, dị dạng mạch, **phẫu thuật thất bại**.
- Chẩn đoán dựa trên **bệnh sử** (thời gian, tần suất, lượng máu, nguyên nhân), **lâm sàng** (khám mũi, họng, dấu sinh tồn), **cận lâm sàng** (nội soi, điện tim, huyết học, hình ảnh).

7. XỬ TRÍ BAN ĐẦU

- **Ép điểm mạch:** đang chảy máu → **bóp chặt hai lỗ mũi** = **nghiệm pháp Hippocrate**.
- **Đốt hóa chất (nitrat bạc): chỉ chấm đúng điểm chảy máu**; bôi lan tỏa gây viêm, nhiễm trùng → **thủng vách ngăn**; **tránh đốt 2 bên**. Sau đó có thể dùng **kem chlorhexidin – neomycin** ngừa tái phát, thúc đẩy lành.
- **Đốt điện** đơn cực / lưỡng cực, hoặc **laser** (có thể qua nội soi, ví dụ chảy từ ĐM bướm khẩu cái).
- **Nhét meche mũi trước:** khi đốt không kiểm soát, chảy nhiều hoặc **không xác định được vị trí**. **Merocel** đặt theo hướng **ngang, song song sàn khẩu cái cứng**.
  - Theo dõi sát **6 giờ đầu**; **để meche tối đa 48 giờ**; rút **chậm, nhẹ tay**; rút xong **kiểm tra thành sau họng**.
  - **Kháng sinh** suốt thời gian còn meche: **amoxicillin 50 – 100 mg/kg/ngày chia 3 lần**.
- **Nhét meche mũi sau:** chảy nhiều do tổn thương **sau trên hốc mũi** hoặc meche trước thất bại. **Bóng 2 van:** bóng 1 bơm căng, kéo ra trước **chèn cửa mũi sau**; bóng 2 chèn hốc mũi trước.

- **Tháo sau 24 giờ** – để lâu gây **nhiễm khuẩn tai giữa**. Chảy khó cầm có thể lót **spongel (xốp tự tiêu)** rồi nhét meche đè lên.

8. PHẪU THUẬT VÀ CAN THIỆP

- **Thắt ĐM cảnh ngoài:** hạn chế chảy máu từ **nhánh ngoại vi**; rạch ngang **giữa xương móng và bờ trên sụn giáp**; biến chứng **nhồi máu não, thiếu máu não**.
- **Thắt ĐM hàm trong:** ở **hố chân bướm hàm**; thành công **khoảng 90%**; tiếp cận qua **Caldwell – Luc** hoặc **nội soi mũi xoang** (clip).
- **Thắt ĐM bướm – khẩu cái:** thành công **trên 95%**.
- **Thắt ĐM sàng trước và sau** (đường ngoài): chảy máu **phía trên cuốn mũi giữa** không cầm được bằng đốt hay meche.
- **Ghép da vách ngăn:** cho **giãn mao mạch xuất huyết di truyền** (đã đốt hóa chất, điện, laser nhiều lần).
- **Chỉnh hình vách ngăn: lệch vách nhiều, u vách ngăn**, chảy máu sau mào vách, hoặc lệch vách cản trở cầm máu.
- **Thuyên tắc mạch:** bệnh nhân **không thể gây mê / phẫu thuật** hoặc **thất bại các phương pháp khác**; chụp mạch rồi bơm vật liệu tạo huyết khối; thành công **71 – 95%**.
- Lưu ý: **không thắt ĐM cảnh trong** để cầm máu mũi.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế bài giảng gốc. Đối chiếu 2. CHAY MAU MUI 1.pdf khi cần chi tiết.